

УДК 616.24-006-06

М.И.Бейшембаев, А.А.Фединчик, К.А.Абакиров, Р.И.Лягазов
Национальный центр онкологии, МЗ Кыргызстан

Возможности комбинированного и комплексного лечения метастатических плевритов в онкологии

Аннотация: Цель исследования - Улучшения результатов лечения метастатических плевритов при использовании комбинированных и комплексных методов местного и системного лечения. В торакальном отделении Национального Центра Онкологии с 2002 по 2014 гг. проведен ретроспективный анализ комбинированного и комплексного лечения у 120 больных с метастатическими плевритами. Показатель 3 - летней выживаемости после проведенного лечения у больных группы «А» составил $12,5 \pm 3,4\%$, у больных группы «Б» - $15 \pm 3,7\%$ и в группе «С» - $20 \pm 4,2\%$.

Ключевые слова: метастатический плеврит, системная химиотерапия, внутриплевральная терапия.

Актуальность проблемы. Метастатический плеврит – одно из весьма распространенных злокачественных поражений плевральной полости, характеризующийся образованием и накоплением в ней жидкости. Как правило, возникает на более поздних этапах опухолевого процесса, указывая на его распространенность. Интенсивное увеличение частоты выявляемости диссеминированных форм рака молочной железы, легкого, яичников, мезотелиомы плевры и лимфосарком, нередко сопровождающихся метастатическим плевритом, отличаются своеобразными клинико-морфологическими особенностями и крайне непредсказуемым течением, обуславливая актуальную проблему в современной онкологии [6].

Основным методом лечения метастатических плевритов все же остается внутриплевральная терапия, в основе которой лежит эвакуация жидкости из плевральной полости с последующим введением цитостатических и склерозирующих препаратов, использующиеся у большинства данной категории больных [2,5].

В настоящее время в ведущих онкологических центрах в лечении метастатических плевритов широко используются комбинации методов местного и системного воздействия, предусматривающих применение системной химиотерапии с внутриплевральной иммунотерапией, химио- и/или склерозирующей терапией. В основе применения комбинированных и комплексных методов лечения лежит одновременное терапевтическое воздействие и на метастатическое поражение плевры и на опухоль основной локализации. Достижение стабилизации процесса, проявляющегося исчезновением выпота в плевральной полости при улучшении общего состояния больных, позволяет более целенаправленно продолжать планируемое лечение опухоли основной локализации [1,3,4].

Материал и методы. В торакальном отделении Национального центра онкологии проведено ретроспективное исследование комбинированного и комплексного лечения метастатических плевритов у 120 больных за период с 2004 по 2014 гг. Больные были разделены на три группы:

1. Группа «А», включала 40 (33,3) больных, получивших системную химиотерапию + внутриплевральную иммунотерапию, которая проводилась Ронколейкином 250 тыс. МЕ/мл, через день. Всего количество введений составляло 2-4.

2. Группа «Б», состояла из 40 (33,3%) пациентов, которым проводилась системная химиотерапия + внутриплевральная химиотерапия, в качестве которой использовали Этопозид 200 мг, Карбоплатин 450 мг и Фторурацил 750 мг, препараты внутриплеврально вводились через день, всего введений - 3-6.

3. Группа «С» - 40 (33,3%): системная химиотерапия + внутриплевральная химио-склерозирующая терапия.

Системная химиотерапия в группах «А», «Б» и «С» проводилась по схемам: CP, CC, CMF, CAF, CAP, CG, EP, EC, ACOP, по 5-6 курсов.

Внутриплевральная химио-склерозирующая терапия у больных группы «С» проводилась Доксифлюрином 250 мг и Циклофосфаном 600 мг, которые были предварительно растворены в 50 мл плазменной жидкости, полученной из периферической крови больного в результате центрифугирования. Цитостатические и склерозирующие препараты, растворенные в аутоплазме, вводились внутриплеврально после максимальной эвакуации жидкости из плевральной полости через день, всего количество введений составляло от 3 до 5.

Основными методами диагностики метастатических плевритов с установлением характера и степени метастатического поражения плевральной полости являлись клинические, лабораторные, рентгенологические, УЗИ плевральной полости и цитоморфологические исследования.

Из 120 больных включенных в исследования: женщин было 88 ($73,3 \pm 2,9\%$), мужчин – 32 ($26,6 \pm 4,2\%$). По возрастным категориям преобладали в основном пациенты среднего и пожилого возраста.

У 46 ($38,3 \pm 4,5\%$) пациентов метастатический плеврит был обусловлен раком молочной железы, у 32 ($26,6 \pm 4,2\%$) пациентов - рак легкого, у 22 ($18,3 \pm 3,7\%$) пациенток – рак яичников, у 12 ($10 \pm 8,8\%$) пациентов плеврит был вызван мезотелиомой плевры, у 8 больных ($6,6 \pm 2,4\%$) - лимфосаркомой.

У всех исследуемых больных диагноз основного опухолевого заболевания был гистологически верифицирован. При этом у больных раком легкого преобладал плоскоклеточный рак ($68,7\%$), у больных раком молочной железы – протоковый рак ($60,8\%$), у пациентов раком яичников доминировала серозная аденокарцинома ($59,0\%$), у больных лимфосаркомами – лимфоцитарная лимфома (75%), у больных мезотелиомой – злокачественная мезотелиома плевры (100%).

У подавляющего большинства больных симптоматика метастатического плеврита дополняла клинические

проявления основного заболевания. Так одышка, кашель и симптомы интоксикации наблюдались у всех больных (100%), тяжести и боли в грудной клетке на стороне поражения отмечались у 81 (67,5±3,5%) больного, гипертермия – у 46 (38,3±4,5%) пациентов, тахикардия – у 78 (65±3,7%).

У 54 (45±4,5%) больных опухолевый процесс был распространенным, из них у 36 (30±4,3%) больных имелись метастазы в различных органах, у 18 (15±3,5%) пациентов наблюдалось метастатическое поражение периферических лимфатических узлов.

По общему состоянию: удовлетворительное состояние наблюдалось у 66 (55±4,3%) пациентов, состояние средней тяжести – 44 (36,6±4,5%) пациентов, тяжелое состояние отмечалось у 10 (8,3±2,5%) больных.

Результаты исследования и их обсуждение. Критерием эффективности после проведенного лечения являлось уменьшение или исчезновение выпота в плевральной полости, сопровождающееся уменьшением клинической симптоматики и улучшением состояния самих больных, которое определялось клинико-лабораторными и рентгенологическими методами исследования. Исходя из этого, улучшение общего состояния после лечения наблюдалось у 92 (76,6±2,4%) больных, ухудшение – у 15 (12,5±3,2%), без изменений (на прежнем уровне) – у 13 (10,8±3,0%) пациентов.

Так, после лечения у большинства исследуемых больных отмечалось уменьшение клинических проявлений метастатического плеврита. При этом одышка, кашель уменьшились у 86 (71,6±3,1%) больных, усилились у 15 (12,5±3,2%) и без изменений у 19 (15,8±3,5%) больных. Боли в грудной клетке уменьшились у 78 (65±7,8%) больных, усилились у 19 (15,8±3,5%) и у 23 (19,1±3,8%) пациентов на прежнем уровне. Симптомы интоксикации, проявляющиеся слабостью, недомоганием, отсутствием аппетита, головокружением уменьшились у 75 (62,3±3,0%) больных, у 25 (20,8±3,9%) без изменений и у 20 (16,6±3,6%) пациентов наблюдалось усиление интоксикации, что требовало проведение адекватного симптоматического лечения.

Таблица 1 - Осложнения лекарственной терапии у 120 больных, после комбинированного и комплексного лечения

Признаки	Группа «А» в %	Группа «Б» в %	Группа «С» в %	Всего
Диспепсические расстройства	22 (55±6,5%)	24 (60±6,7%)	15 (37,5±5,6%)	61 (50,8±4,4%)
Анемия и лейкопения	18 (45±5,6%)	16 (40±5,7%)	12 (30±5,1%)	46 (38,3±4,5%)
Лихорадка	12 (30±5,1%)	13 (32,5±5,3%)	9 (22,5±4,5%)	34 (28,3±4,3%)
Боли в грудной клетке	16 (40±5,7%)	17 (42,5±5,9%)	12 (30±5,1%)	45 (37,5±4,5%)
Интоксикация	26 (65±6,9%)	24 (60±6,7%)	20 (50±6,3%)	70 (58,3±4,1%)
Прочие	10 (25±4,7%)	12 (30±5,1%)	8 (20±4,2%)	30 (25±4,1%)

Как видно из представленных данных таблицы №1 показано, что у 61 (50,8±4,4%) пациента, из них у 22 (55±6,5%) из группы «А», у 24 (60±6,7%) группы «Б» и у 15 (37,5±5,6%) группы «С» наблюдались диспепсические расстройства в виде тошноты, рвоты, диареи и болей в животе. У 46 (38,3±4,5%) пациентов: из них у 18 (45±5,6%) группы «А», у 16 (40±5,7%) пациентов группы «Б» и у 12 (30±5,1%) группы «С» наблюдались изменение показателей крови (анемия, лейкопения). У 34 (28,3±4,3%) больных из них у 12 (30±5,1%) группы «А», у 13 (32,5±5,3%) пациентов из группы «Б» и у 9 (22,5±4,5%) группы «С» отмечалась субфебрильная лихорадка. У 70 (58,3±4,1%) больных из них у 26 (65±6,9%) из группы «А», у 24 (60±6,7%) группы «Б» и у 20 (50±6,3%) пациентов из группы «С» наблюдались симптомы интоксикации (слабость, недомогания, головокружение, отсутствие аппетита т.д.). У 30 (25±4,1%) больных из них у 10 (25±4,7%) группы «А», у 12 (30±5,1%) пациентов из группы «Б» и у 8 (20±4,2%) из группы «С» отмечались прочие осложнения, основу которых составляли кардио-нефротоксичность, дерматит, костно-суставной синдром.

Таблица 2 - Оценка непосредственных результатов проведенного лечения.

Критерии	Группа «А» в %	Группа «Б» в %	Группа «С» в %	Всего
полная ремиссия	8 (20±4,2%)	10 (25±4,7%)	12 (30±5,1%)	30 (25±4,1%)
частичная ремиссия	13 (32,5±5,3%)	15 (37,5±4,0%)	17 (42,5±5,9%)	45 (37,5±4,5%)
без динамики	7 (17,5±4,0%)	6 (15±3,7%)	5 (12,5±3,4%)	18 (15±3,5%)
прогрессирование	12 (30±5,1%)	9 (22,5±4,5%)	6 (15±3,7%)	27 (22,5±4,0%)

Согласно представленным данным установлено, что у 30 (25±4,1%) пациентов, из них у 8 (20±4,2%) из группы «А», у 10 (25±4,7%) пациентов из группы «Б» и у 12 (30±5,1%) пациентов из группы «С» наблюдалась полная стабилизация процесса, проявляющаяся отсутствием накопления жидкости в плевральной полости продолжительностью 6 месяцев. Частичная стабилизация (ремиссия) – наличие небольшого количества жидкости в плевральной полости, не требующая ее удаления, наблюдалась у 45 (37,5±4,5%) больных: у 13 (32,5±5,3%) из группы «А», у 15 (37,5±4,0%) пациентов из группы «Б» и у 17 (42,5±5,9%) больных из группы «С». У 18 (15±3,5%) больных: у 7 (17,5±4,0%) из группы «А», у 6 (15±3,7%) пациентов из группы «Б» и у 5 (12,5±3,4%) пациентов из группы «С» динамика была прежним уровне,

как до лечения. У 27 ($22,5 \pm 4,0\%$) больных: у 12 ($30 \pm 5,1\%$) из группы «А», у 9 ($22,5 \pm 4,5\%$) больных из группы «Б» и у 6 ($15 \pm 3,7\%$) пациентов из группы «С» наблюдалось дальнейшее прогрессирование опухолевого процесса.

Ведущими прогностическими факторами, влияющими на выживаемость у данной категории больных после проведенного лечения, являются характер и степень метастатического поражения плевральной полости, распространенность опухолевого процесса, морфологические особенности опухолей основных локализаций.

Показатели смертности у больных с метастатическими плевритами после проведенного лечения представлены на рисунке 1.

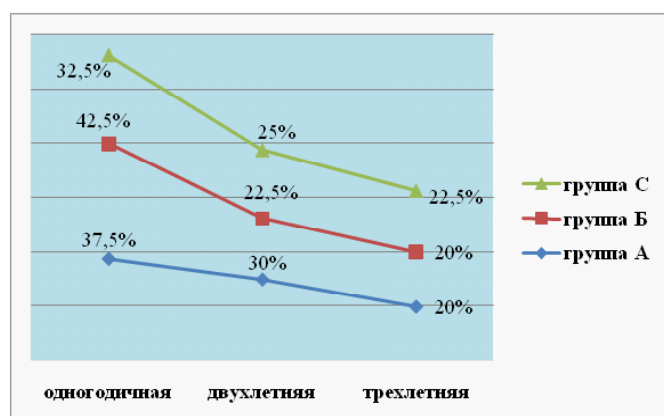


Рисунок 1 - Сравнительные показатели смертности у больных с метастатическими плевритами

Как видно из представленных данных графика №1, одногодичная летальность у больных группы «А» составляла $37,5 \pm 5,6\%$, двухгодичная – $30 \pm 5,1\%$, трехлетняя составила $20 \pm 4,2\%$. У больных группы «Б» показатели одногодичной, двухгодичной и трехгодичной летальности составили $42,5 \pm 5,9\%$; $22,5 \pm 4,5\%$ и $20 \pm 4,2\%$ соответственно. У больных группы «С» – одногодичная летальность составила $32,5 \pm 5,3\%$, двухгодичная – $25 \pm 4,7\%$, трехлетняя – $22,5 \pm 4,5\%$.

Показатели сравнительной выживаемости у больных с метастатическими плевритами представлены на рисунке 2.

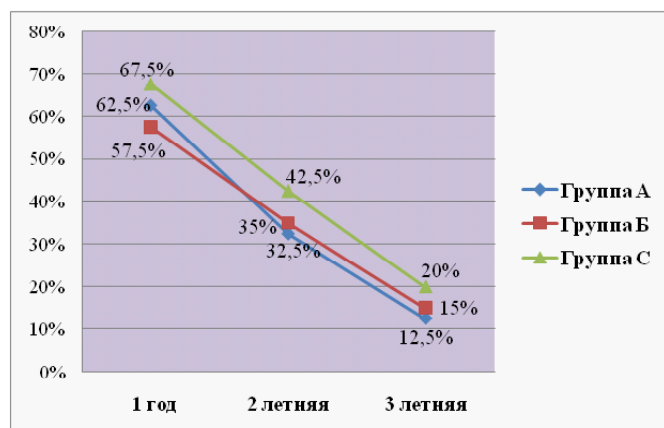


Рисунок 2 - Показатели выживаемости после комбинированного и комплексного лечения

Согласно представленным данным (рисунок 2) следует, что показатель одногодичной выживаемости у больных группы «А» составил $62,5 \pm 6,8\%$. Одногодичная выживаемость у больных группы «Б» составила $57,5 \pm 6,6\%$, в то время как у пациентов группы «С» – показатель одногодичной выживаемости составил $67,5 \pm 7,0\%$.

Двухлетняя и трехлетняя выживаемость у больных группы «А» составляла $32,5 \pm 5,3\%$ и $12,5 \pm 3,4\%$ соответственно. У пациентов группы «Б» двухлетняя выживаемость составила $35 \pm 5,4\%$ и трехлетняя – $15 \pm 3,7\%$. У пациентов группы «С» двухлетний рубеж составил $42,5 \pm 5,9\%$, показатель трехлетней выживаемости составил $20 \pm 4,2\%$.

Необходимо отметить, что трехлетний срок прожили преимущественно те больные, у которых метастатический плеврит был обусловлен раком молочной железы и раком яичников при отсутствии дальнейшего их прогрессирования.

Таким образом, в ходе проведенного ретроспективного исследования было установлено, что применение системной химиотерапии с внутриплевральной химиосклерозирующей терапией с использованием биоразтворителя (аутоплазма) у больных с метастатическими плевритами, увеличивает показатели одногодичной, двухлетней и трехлетней выживаемости на $67,5 \pm 7,0\%$, $42,5 \pm 5,9\%$ и $20 \pm 4,2\%$ по сравнению с традиционными комбинированными методами системного и местного лечения. При этом следует подчеркнуть, что растворение цитостатических и склерозирующих препаратов в аутоплазме позволяло уменьшить частоту осложнений, возникающих в процессе терапии, способствуя лучшей переносимости внутриплеврального лечения за счет связывания с белками плазмы лекарственных препаратов, с образованием так называемых ксенобиотиков.

Список литературы

1. Алексеева Т.Р., Лебедев В.В., Иванова Т.Д., Некрасов А.В. Современные подходы комбинированного и комплексного лечения метастатических плевритов у больных со злокачественными новообразованиями. - РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН. - М., 2008.
2. Ларионова Н.А., Петренко А.Л., Васильева Н.И. Пути улучшения качества жизни онкологических больных с метастатическими плевритами // Мат. 8-й ежегодной Российской онкологической конференции, 16-18 декабря 2007. - С. 34.
3. Поддубная И.В., Горбунова В.А., Летягин В.П. Внутривезикулярная терапия опухолевых плевритов // Мат. МНИОИ им П.А. Герцена, М., 2004.
4. Шубина И. Ж., Волков С.М., Демидов Л. В., Киселевский М. В. Адоптивная иммунотерапия злокачественных новообразований // Вестник РАМН. - 2008. - №11. - С. 9-15.
5. Borger D.P., Carlson K.J., Pike M.C. et al. Intravascular therapy in malignant pleural effusions // Thorax Oncology-Philadelphia; Lippincott, 2004-P. 2729-2744.
6. Henderson B.D., Hatch F.G., Leong S.S. et al. Malignant pleural effusion epidemiology, diagnostic and treatment // European Respiratory Journal. - 2010. - Vol.20. Suppl 38. - P. 17-41.

Тұжырым

М.И.Бейшембаев, А.А. Фединчик,
К.А.Абакиров, Р.И.Лягасов
Қырғызстанның ДСМ Ұлттық онкология
орталығы

Онкологиядағы метастатикалық плевриттердің қосарланған және біріктірілген емінің мүмкіндіктері

Зерттеудің мақсаты - метастатикалық плевриттерді қосарланған және біріктірілген әдістерінің жергілікті және жүйелі емінің қолдануындағы, ем нәтижелерін жақсарту. Ұлттық онкология орталығында 2002-2014жж. аралығында, торакальды бөлімшеде емделген метастатикалық плевриті бар 120 науқастың қосарланған және біріктірілген емінің ретроспективті сараптамасы жүргізілді. Жүргізілген емнен кейін 3 жылдық өмір сүру көрсеткіші: «А» тобындағы науқастарда $12,5 \pm 3,4\%$, «Б» тобындағы науқастарда - $15 \pm 3,7\%$ және «С» тобындағы науқастарда - $20 \pm 4,2\%$ -ды құрды.

Түйінді сөздер: метастатикалық плеврит, жүйелі химиотерапия, плевраішілік терапия.

Summary

M.I.Beychembaev, A.A.Fedinchik,
C.A.Abakirov, R.I.Lyagasov
The National Center of Oncology,
Kyrgyzstan

Possibilities of combined and complex treatment of metastatic pleuritis in oncology

To Improve the results of treatment of metastatic pleuritis with combined and integrated methods of local and systemic treatment. At the thoracic Department of the National Center of Oncology from 2002 to 2014 years retrospective analysis of combined and complex treatment of 120 patients with metastatic pleuritis. 3-year survival rate after treatment in patients with group «A» was $12.5 \pm 3.4\%$ of patients in Group «B» - $15 \pm 3.7\%$ and in the group «C» - $20 \pm 4.2\%$.

Keywords: metastatic pleural effusion, systemic chemotherapy, intrapleural therapy.